POLÍTICA DE COBERTURA

CIRUGÍA ROBÓTICA (ASISTIDA POR ROBOT)

Índice

1. Política de cobertura 1
2. Resumen de la evidencia disponible 2
Anexos 4
3. 4
3.1. Codificación 4
3.2. Referencias 4
3.3. Unidad responsable e información sobre versión ... 5

Número Política: 059
Fecha creación: marzo 2018
Fecha última actualización: enero 2024

***INSTRUCCIONES**: La política de coberturas aporta una guía de interpretación de las garantías cubiertas en las pólizas de Adeslas SegurCaixa. Por favor preste atención a este hecho, ya que las garantías en ciertos colectivos y en pólizas individuales pueden diferir de lo expuesto en las políticas de cobertura si la póliza recoge de forma explícita garantías adicionales. En caso de conflicto, siempre el contenido de la póliza se impone sobre las políticas generales de cobertura.*

1. Política de cobertura

SegurCaixa Adeslas **CUBRE** la cirugía robótica para todos sus **asegurados públicos** dado que los conciertos de mutualidades (2022-2024) así la incluyen en las siguientes indicaciones):

a) Cirugía Urológica: Cáncer de próstata (prostatectomía radical).

- Criterios de inclusión:
  - *Pacientes diagnosticados de adenocarcinoma prostático localizado.*
  - *PSA < 15 ng/ml.*
  - *Ecografía transrectal de próstata sin evidencia de afectación extracapsular ni afectación de vesículas seminales (T1-T2).*
  - *Sin invasión linfática ni metástasis (N0 y M0).*
  - *Riesgo ASA < III.*

b) Carcinoma renal: nefrectomía parcial.

- Indicaciones:
  - *Tumores de predominio exofítico < 4 cm.*
  - *En monorrenos tumores < 4 cm.*

c) Cirugía Ginecológica: Tumores de endometrio (histerectomía total)

Indicaciones: *Tumor endometrio localizado.*

Este documento es de uso exclusivo del personal de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros.
Queda prohibida su reproducción y divulgación sin autorización expresa

d) Cirugía General y del Aparato Digestivo: Cirugía Esófago-Gástrica.

- Indicaciones: *Gastrectomía por tumor gástrico localizado.*

e) Cirugía Colo-Rectal:

- Indicaciones: *Tumor colo-rectal localizado.*

SegurCaixa Adeslas **CUBRE** la cirugía robótica para sus asegurados de **pólizas privadas, exclusivamente** en los términos estrictamente **recogidos** de manera expresa en los **condicionados** desde enero de 2024**.** Las indicaciones médicas en cobertura para esta técnica vienen así recogidas:

a) En el tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata mediante prostatectomía radical en aquellos casos que cumplan todos los siguientes criterios:

1. Diagnóstico de tumor maligno prostático localizado
2. PSA menor o igual a 15 ng/ml en el momento de la indicación quirúrgica
3. Ausencia de afectación extracapsular y/o de vesículas seminales en la ecografía transrectal o medios de imagen (tumor estadificado como T1 o T2)
4. Ausencia de evidencia de metástasis y/o invasión linfática (tumor estadificado como N0 y M0)
5. Riesgo anestésico del paciente ASA menor a III

b) En el tratamiento quirúrgico, mediante nefrectomía parcial, del carcinoma renal (exclusivamente en tumores menores de 4 cm en su diámetro mayor).

SegurCaixa Adeslas **NO CUBRE** la cirugía robótica (el proceso completo de la cirugía) ni en asegurados públicos ni en pólizas privadas en otras indicaciones de las señaladas anteriormente. En el caso de funcionarios será necesario ofrecer y gestionar una alternativa asistencial válida con medios no robóticos (como recoge el concierto). Esto supone la no cobertura de la cirugía robótica ya sea directa o asistida (entendiendo en ambos casos las intervenciones realizadas mediante (maniobras quirúrgicas que realiza un robot siguiendo las instrucciones de un cirujano y guiado por un sistema laparoscópico telerrobotizado, y/o la que realiza el robot asistida por un sistema informatizado de realidad virtual o navegador con imágenes en 3D obtenidas por ordenador).

SegurCaixa Adeslas **CUBRE** la cirugía robótica en **algunos colectivos privados** (entre otros: Iberdrola, Repsol, Garrigues…). Las condiciones específicas de cobertura están detalladas en cada uno de los condicionados de las pólizas de dichos colectivos.

2. Resumen de la evidencia disponible

La cirugía robótica permite realizar procesos laparoscópicos, mínimamente invasivos, en múltiples indicaciones.

Sistema Da Vinci

El dispositivo *da Vinci® Surgical System* usa una tecnología robótica dirigida que permite a los cirujanos realizar operaciones a través de pequeñas incisiones (1 - 2 cm).

Se trata de un sistema con el cual el cirujano dirige los brazos del robot a través de una consola de operaciones próxima al área quirúrgica. Este sistema permite que los movimientos de la mano del cirujano sean más finos y precisos, ya que dispone de una ampliación visual del campo quirúrgico en tres dimensiones y anula el temblor

de manos y los posibles movimientos involuntarios del cirujano. El Sistema da Vinci no se puede programar y tampoco puede tomar decisiones por su cuenta, necesitando una orden directa del cirujano para realizar cada maniobra quirúrgica.

Entre las ventajas que se le atribuyen a este sistema se encuentran una mayor precisión, menos errores, menor trauma para el paciente, cicatrices más pequeñas, menos sangrado, así como un tiempo de hospitalización más limitado y una recuperación precoz y con menos dolor. Así mismo se han detectado problemas en su aplicación, tales como falta de retroalimentación táctil, mayor tiempo requerido para el desarrollo de la intervención, elevados costes una curva de aprendizaje necesaria.

Los estudios incluidos en el **Informe de la AETSA 2017** sobre las Indicaciones de la Cirugía Robótica presentan la cirugía robótica como una técnica segura para cada una de las indicaciones en las que ha sido utilizada. De forma general, las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas (laparoscópica y robótica) se muestran superiores a la cirugía convencional.

En relación a la cirugía robótica frente a la laparoscópica, la primera presenta una mayor duración del acto quirúrgico pero menor pérdida de sangre durante el mismo. No hay diferencias entre ambas técnicas en cuanto a presentación de complicaciones postquirúrgicas y estancia hospitalaria.

Dado el gran número de indicaciones en las que se utilizan las técnicas robóticas, y con el fin de facilitar la comprensión de todos los resultados, en la tabla 12 se ofrece un resumen de todas ellas. Se ha establecido un sistema de identificación por colores según la evidencia encontrada en cada una de ellas:

- A favor de las técnicas robóticas: color **verde**.
- A favor de las técnicas laparoscópicas o de la cirugía abierta: color **rojo**.
- Sin diferencia entre las técnicas: color **amarillo**.
- No se ha recuperado ningún tipo de evidencia científica al respecto: color **gris**.

Tabla 12. Comparación de resultados de la cirugía robótica versus laparoscópica.

Indicación		Duración intervención	Conversión	Pérdida de sangre	Transfusión	Complicaciones	Estancia hospitalaria	Calidad de vida	Dolor
Cía. Cardiotorácia[2,5]		Mayor				Menor	Menor		
Cía ginecológica	Histerectomía[4-6]	Mayor[5] SD[6]	Menor	Menor	SD	Menor	Menor	Mayor	
	Colposacropexia[4,6,7]	Mayor				SD	SD	SD	Mayor
	Miomectomía	SD		SD	SD	SD	SD		
	Reversión esterilización tubárica								
Cía urológica	Cistectomía[2,4,10] (robótica vs abierta)	Mayor		Menor	Menor	Menor	Menor		
	Prostatectomía[2,4,5]	Mayor		Menor		Menor	Menor	Mayor	
	Nefrectomía[5]	Mayor				Menor	Menor		
	Adrenalectomía[4,12]	SD		SD		SD	SD		
	Trasplante renal[11] (robótica vs abierta)					Menor	Menor		Menor
Cía general	Cía bariátrica[2,3,13]	SD				Menor	Menor		
	Cía en tumores gástricos[14]	SD		SD		SD	SD		
	Colecistectomías[15]	SD	SD						
	Cía colorrectal[4,5,16,17]	Mayor	SD	SD	SD	SD	Menor		
	Cía pancreática[18]	SD	SD			SD	Menor		
	Tiroidectomía[19] (robótica vs abierta)	Mayor				SD	SD		

Cía: cirugía; SD: sin diferencias

Las indicaciones que aparecen sombreadas en naranja (cistectomía, trasplante renal y tiroidectomía) son aquellas en las que los resultados encontrados hacen referencia a la comparación entre cirugía robótica y abierta, sin comparar con la técnica laparoscópica en esos casos.

Código de colores para los resultados:
ROJO: resultado a favor de la cirugía laparoscópica;
VERDE: resultado a favor de la cirugía robótica;
AMARILLO: sin diferencia entre ambas técnicas;
GRIS: no hay datos al respecto.

3. Anexos

3.1. Codificación

NOMENCLÁTOR			
Cód. Esp	**Especialidad**	**Cód. Acto**	**Descripción Acto**
41	UROLOGÍA	8900	PROSTATECTOMIA CON CIRUGÍA ROBOTIZADA
41	UROLOGÍA	8901	NEFRECTOMÍA CON CIRUGÍA ROBOTIZADA
31	GINECOLOGÍA	8015	HISTERECTOMÍA TOTAL CON CIRUGÍA ROBOTIZADA
11	CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO	8016	CIRUGÍA ESOFAGO-GÁSTRICA CON CIRUGÍA ROBOTIZADA
11	CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO	8017	CIRUGÍA COLORRECTAL CON CIRUGÍA ROBOTIZADA

3.2. Referencias

1. López N, Baños E, Benot S. *Indicaciones de Cirugía Robótica*. Agencia de Evaluación de Tecnologías sanitarias de Andalucía (AETSA). 2017
2. Tan A, Ashrafian H, Scott AJ et al. *Robotic Surgery: disruptive innovation or unfulfifilled promise? A systematic review and meta-analysis of the first 30 years*. Surgical Endoscopy 2016; 30: 4330-4352
3. Intuitive Surgical, Inc. Intuitive Surgical, Inc. Annual report 2015. California (EEUU): Intuitive Surgical, Inc.; 2015.
4. Lorenzon L, Bini F, Balducci G, et al. *Laparoscopic versus robotic-assisted colectomy and rectal resection: a systematic review and meta-analysis*. Int J Colorectal Dis. 2016; 31:161–73.
5. Lavazzo C, Mamais I, Gkegkes ID. *Robotic assisted vs laparoscopic and/or open myomectomy: systematic review and meta-analysis of the clinical evidence*. Arch Gynecol Obstet. 2016; 294: 5–17.
6. Liu H, Lawrie TA, Lu D, et al. *Robot-assisted surgery in gynaecology*. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD011422.
7. Ilic D, Evans SM, Allan CAnn,. *Laparoscopic and robotic-assisted versus open radical prostatectomy for the treatment of localised prostate cancer*. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD009625.
8. Asimakopoulos AD, Miano R, Annino F et al. Robotic radical nephrectomy for renal cell carcinoma: a systematic review. BMC Urol. 2014 Sep 18; 14:75. doi: 10.1186/1471-2490-14-75

3.3. Unidad responsable e información sobre versión

- Departamento de Asesoría Médica y Mutualidades

FECHA	VERSIÓN	NATURALEZA DEL CAMBIO
marzo 2018	01	Creación
julio 2018	02	Actualización
marzo 2020	03	Actualización
noviembre 2022	04	Actualización
Enero 2024	05	Titulo no restringido a Da Vinci. Inclusión cobertura pols. Privadas. Especificación de exclusión